



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 208.3/I-KEP/DIR/IV/2026**

**TENTANG
PANDUAN KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa dalam memberikan asuhan pasien yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien setiap tenaga harus memenuhi syarat kredensial;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/342/2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1910/2022 tentang Standar Profesi Dietisien;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/313/2020 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/316/2020 tentang Standar Profesi Radiografer;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/314/2020 tentang Standar Profesi Elektromedis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima medika Nomor 773.145/I-KEP/DIR/V/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada malang;
13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 233.10/DPM/I-KEP/DIR/IV/2026 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG
PANDUAN KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL**

Kedua : **BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit ini yang dimaksud dengan:



- 1) Kredensial adalah proses evaluasi oleh suatu rumah sakit terhadap seorang staf medis untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi penugasan klinis dan kewenangan klinis untuk menjalankan asuhan/ tindakan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit tersebut untuk periode tertentu.
- 2) Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap tenaga keperawatan yang telah memiliki Kewenangan Klinis untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan klinis.
- 3) Kewenangan klinis tenaga keperawatan adalah uraian intervensi keperawatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kompetensi di area praktiknya.

BAB II PENUGASAN STAF MEDIS

Pasal 2

- 1) Rumah sakit mempunyai regulasi tentang perjanjian kerja staf medis yang antara lain meliputi kredensial, rekredensial, dan penilaian kinerja.
- 2) Proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja, dan rekredensial staf medis diatur dalam peraturan internal staf medis.
- 3) Setiap dokter yang memberikan pelayanan di rumah sakit wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan regulasi rumah sakit.
- 4) Pelaksanaan verifikasi ijazah dilakukan setelah pemanggilan seleksi staf medis.
- 5) Pada saat proses kredensial, staf medis harus melengkapi STR, Ijazah, SIP, dan Sertifikat pelatihan yang menunjang kompetensi masing-masing SMF.
- 6) Terdapat permohonan kredensial atau rekredensial dari Direktur Rumah Sakit untuk staf medis yang akan melakukan proses kredensial dan rekredensial.
- 7) Ada proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis oleh rumah sakit untuk pelayanan diagnostik, konsultasi, dan tata laksana yang diberikan oleh dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit seperti kedokteran jarak jauh (*telemedicine*), radiologi jarak jauh (*teleradiology*), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostik lain: elektrokardiogram (EKG), elektroensefalogram (EEG), elektromiogram (EMG), serta pemeriksaan lain yang serupa.
- 8) DPJP yang ditetapkan telah memenuhi proses kredensial yang sesuai dengan peraturan perundangan.
- 9) Proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja, dan rekredensial staf medis diatur dalam peraturan internal staf medis (*medical staff by laws*).
- 10) Setiap dokter yang memberikan pelayanan di rumah sakit wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan regulasi rumah sakit.
- 11) Ada proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis oleh rumah sakit untuk pelayanan diagnostik, konsultasi, dan tata laksana yang diberikan oleh dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit seperti kedokteran jarak jauh (*telemedicine*), radiologi jarak jauh (*teleradiology*), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostik lain: elektrokardiogram (EKG), elektroensefalogram (EEG), elektromiogram (EMG), serta pemeriksaan lain yang serupa.
- 12) Ada bukti dilaksanakan verifikasi dari sumber utama terhadap kredensial terkait pendidikan, izin/sertifikat, dan kredensial lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan atau organisasi profesional yang diakui.
- 13) Ada bukti dilaksanakan kredensial tambahan dari sumber yang mengeluarkan kredensial apabila staf medis meminta kewenangan klinis canggih atau subspesialisasi
- 14) Pengangkatan staf medis dibuat berdasar atas regulasi rumah sakit dan konsisten dengan populasi pasien rumah sakit, misi, dan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien



- 15) Pengangkatan tidak dilakukan sampai setidaknya izin/surat tanda registrasi sudah diverifikasi dari sumber primer dan anggota staf medis kemudian melakukan pelayanan perawatan pasien di bawah supervisi sampai semua kredensial yang disyaratkan undang-undang dan peraturan sudah diverifikasi dari sumber asli
- 16) Untuk staf medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri, dilakukan metode supervisi, frekuensi supervisi, dan supervisor yang ditunjuk didokumentasikan di arsip kredensial individu tersebut

PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS STAF MEDIS

Pasal 3

- 1) Direktur menetapkan kewenangan klinis setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik termasuk kewenangan tambahan.
- 2) Ada bukti pemberian kewenangan klinis berdasar atas rekomendasi kewenangan klinis dari Komite Medik.
- 3) Ada bukti pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan setelah melakukan verifikasi dari sumber yang mengeluarkan kredensial.
- 4) Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis anggota staf medis dalam bentuk tercetak atau elektronik (softcopy) atau media lain tersedia di semua unit pelayanan (contoh: kamar operasi, unit darurat, nurse station) tempat anggota staf medis tersebut memberikan pelayanan.
- 5) Setiap anggota staf medis hanya memberikan pelayanan spesifik yang ditentukan oleh rumah sakit.

BAB III

STAF KEPERAWATAN

Pasal 4

- 1) Ada regulasi rumah sakit dengan proses yang efektif untuk mengumpulkan, verifikasi dan mengevaluasi kredensial stafkeperawatan (pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman).
- 2) Tersedia dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman.
- 3) Terdapat pelaksanaan verifikasi dari sumber aslinya yang seragam.
- 4) Ada dokumen kredensial yang dipelihara dari setiap anggota staf keperawatan.

KEWENANGAN KLINIS STAF PERAWAT

Pasal 5

- 1) Ada penetapan rincian kewenangan klinis perawat berdasar atas pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman anggota staf keperawatan.
- 2) Ada pelaksanaan proses pembuatan rincian kewenangan klinis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ada berkas kredensial yang dipelihara dari setiap staf keperawatan

BAB IV

STAF KLINIS PEMBERI ASUHAN PASIEN

Pasal 6

- 1) Ada regulasi rumah sakit untuk proses yang efektif untuk mengumpulkan, verifikasi dan mengevaluasi kredensialprofesional



pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya (pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman).

- 2) Tersedia dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman.
- 3) Terdapat pelaksanaan verifikasi dari sumber aslinya yang seragam.
- 4) Ada dokumen kredensial yang dipelihara dari setiap anggota profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya

APOTEKER

Pasal 7

- 1) Apoteker harus memiliki kompetensi yang relevan dalam memberikan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan tentang praktik kefarmasian.
- 2) Apoteker yang sebagaimana dimaksud di atas memenuhi persyaratan kredensial.

ANALIS KESEHATAN

Pasal 8

- 1) Staf laboratorium yang membuat interpretasi, memenuhi persyaratan kredensial.
- 2) Staf laboratorium dan staf lain yang melaksanakan tes termasuk yang mengerjakan Tes di Ruang Rawat (*TRR/ Point of Care Testing*) pasien, memenuhi persyaratan kredensial.

RADIOGRAFER

Pasal 9

- 1) Staf radiodiagnostik, imaging dan radiologi intervensional (RIR) dan staf lain yang melaksanakan tes termasuk yang mengerjakan pelayanan pasien di tempat tidur (*point-of-care test*) pasien, memenuhi persyaratan kredensial
- 2) Staf radiodiagnostik, imaging dan radiologi intervensional (RIR) yang membuat interpretasi/ ekspertise memenuhi persyaratan kredensial

PROFESI GIZI

Pasal 10

Ahli gizi harus memiliki kompetensi yang relevan dalam memberikan pelayanan gizi dan memenuhi persyaratan kredensial

PEREKAM MEDIS

Pasal 11

Perekam medis harus memiliki kompetensi yang relevan dalam memberikan pelayanan dan memenuhi persyaratan kredensial.

AKADEMIK TEKNIK ELEKTROMEDIK (ATEM)

Pasal 12

ATEM harus memiliki kompetensi yang relevan dalam memberikan pelayanan dan memenuhi persyaratan kredensial

BAB V VERIFIKASI

Pasal 13



- 1) Pelaksanaan verifikasi dari sumber utama terhadap kredensial terkait pendidikan, izin/sertifikat, dan kredensial lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan atau organisasi profesional yang diakui.
- 2) Pelaksanaan kredensial tambahan dari sumber yang mengeluarkan kredensial apabila staf medis memintakewenangan klinis canggi atau subspesialisasi.
- 3) Pengangkatan tidak dilakukan sampai setidaknya izin/surat tanda registrasi sudah diverifikasi dari sumber primer dan anggota staf medis kemudian melakukan pelayanan perawatan pasien di bawah supervisi sampai semua kredensial yang disyaratkan undang-undang dan peraturan sudah diverifikasi dari sumber asli.
- 4) Untuk staf medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri, dilakukan metode supervisi, frekuensi supervisi, dan supervisor yang ditunjuk didokumentasikan di arsip kredensial individu tersebut.

BAB VI PEMBAHARUAN KEWENANGAN KLINIS/PENETAPAN ULANG

Pasal 14

- 1) Berdasar atas monitoring dan evaluasi berkelanjutan kredensial anggota staf medis yang dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun ditetapkan kewenangan klinisnya apakah tetap, bertambah, atau berkurang.
- 2) Dokumentasi setiap anggota staf medis selalu diperbaharui secara periodic.
- 3) Dokumentasi pemberian kewenangan tambahan didasarkan atas kredensial yang telah diverifikasi dari sumber aslinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYIMPANAN FILE KREDENSIAL

Pasal 15

- 1) Data dan informasi berasal dari proses monitoring dikaji sekurang-kurangnya setiap 12 bulan oleh kepala unit layanan, ketua kelompok staf medis, subkomite mutu, manajer pelayanan medis. Hasil, simpulan, dan tindakan yang dilakukan didokumentasikan di dalam *file* kredensial staf medis atau dokumen lain yang relevan.

Pasal 16

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 April 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 208.3/I-KEP/DIR/IV/2026
TENTANG PANDUAN KREDENSIAL DAN
REKREDENSIAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Salah satu upaya rumah sakit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan pasiennya adalah dengan menjaga standar profesi dan kompetensi para tenaga kesehatan lain yang melakukan asuhan terhadap pasien di rumah sakit. Upaya ini dilakukan dengan cara mengatur agar setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang benar-benar kompeten. Persyaratan kompetensi ini meliputi dua komponen:

- 1) Komponen kompetensi keprofesian yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional; dan,
- 2) Komponen kesehatan yang meliputi kesehatan fisik dan mental.

Asuhan pasien dilakukan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) dengan banyak disiplin dan staf klinis lain. Semua staf yang terlibat dalam asuhan pasien harus memiliki peran yang jelas, ditentukan oleh kompetensi dan kewenangan, kredensial, sertifikasi, hukum dan regulasi, keterampilan individu, pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan rumah sakit, atau uraian tugas wewenang (UTW).

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Panduan Kredensial dan Rekredensial digunakan sebagai panduan atau acuan bagi manajemen untuk melakukan proses kredensialing bagi staf medis, staf keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya.

1.2.2. Tujuan

Panduan Kredensial dan Rekredensial bertujuan agar dijadikan acuan bagi rumah sakit dalam melaksanakan ketentuan tentang kredensial.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Kredensial dan Rekredensial meliputi pengaturan tentang:

- 1) Kredensial staf medis
- 2) Kredensial staf keperawatan
- 3) Kredensial tenaga kesehatan lain

1.4. Pengertian

- 1) Kredensialing adalah proses evaluasi oleh suatu rumah sakit terhadap seorang staf medis untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi penugasan klinis dan kewenangan klinis untuk menjalankan asuhan/ tindakan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit tersebut untuk periode tertentu.
- 2) Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap tenaga medis yang telah memiliki Kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
- 3) Dokumen kredensial adalah dokumen yang dikeluarkan oleh badan resmi untuk menunjukkan bukti telah dipenuhinya persyaratan seperti ijazah dari fakultas kedokteran, surat tanda registrasi, izin praktik, fellowship, atau bukti Pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat pengakuan dari organisasi profesi kedokteran. Dokumen ini harus diverifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan dokumen. Dokumen



kredensial dapat juga diperoleh dari rumah sakit, perorangan, badan hukum yang terkait dengan riwayat profesional, atau riwayat kompetensi dari pelamar seperti surat rekomendasi, semua riwayat pekerjaan sebagai staf medis di tempat kerja yang lalu, catatan asuhan klinis yang lalu, riwayat kesehatan, dan foto. Dokumen ini akan diminta rumah sakit sebagai bagian dari proses kredensial. Berkas ijazah serta STR harus diverifikasi kepada sumber utamanya. Syarat untuk verifikasi kredensial disesuaikan dengan posisinya. Sebagai contoh, pelamar untuk kedudukan kepala departemen/unit layanan di rumah sakit dapat diminta verifikasi terkait jabatan dan pengalaman administrasi di masa lalu. Untuk posisi staf medis di rumah sakit dapat diminta verifikasi riwayat pengalaman kerja beberapa tahun yang lalu.

- 4) File kredensial dari seorang anggota staf medis harus menjadi sumber informasi yang dinamis dan selalu ditinjau secara teratur. Contohnya, jika seorang anggota staf menyerahkan sertifikat kelulusan sebagai hasil dari pelatihan spesialisasi khusus maka kredensial baru ini harus diverifikasi segera dari sumber yang mengeluarkan sertifikat. Sama halnya, jika instansi dari luar (MKEK/ MKDKI) menyelidiki kejadian sentinel terkait seorang anggota staf medis dan memberi sanksi maka informasi ini harus digunakan untuk evaluasi muatan kewenangan klinis anggota staf medis. Untuk menjamin bahwa *file* staf medis lengkap dan akurat, *file* diperiksa paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali dan ada catatan di tindakan yang diberikan atau tindakan yang tidak diperlukan sehingga penempatan staf medis dapat berlanjut.
- 5) Staf medis adalah semua dokter dan dokter gigi yang memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bedah, atau layanan medis/ gigi lain kepada pasien, atau yang memberikan layanan interpretatif terkait pasien seperti patologi, radiologi, laboratorium, serta memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.
- 6) Verifikasi adalah sebuah proses untuk memeriksa validitas dan kelengkapan kredensial dari sumber yang mengeluarkan kredensial. Proses dapat dilakukan ke fakultas/ rumah sakit/ perhimpunan di dalam maupun di luar negeri melalui email/ surat konvensional/ pertanyaan *online*/ atau melalui telepon. Verifikasi dengan email maka alamat email harus sesuai dengan alamat email yang ada pada website resmi universitas/ rumah sakit/ perhimpunan profesi tersebut dan bila melalui surat konvensional harus dengan pos tercatat.
- 7) Kredensial adalah sebuah proses memeriksa dokumen dari pelamar, wawancara, dan ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk memutuskan apakah seorang memenuhi syarat diberi rekomendasi kewenangan klinis untuk memberikan asuhan pasien yang dibutuhkan pasien. Untuk pelamar baru, informasi yang diperiksa terutama berasal dari sumber luar.
- 8) Rekredensial merupakan sebuah proses kredensial ulang setiap 3 tahun. Dokumen kredensial dan rekredensial meliputi :
 - a. STR, izin praktik yang masih berlaku;
 - b. File pelanggaran etik atau disiplin termasuk informasi dari sumber luar seperti dari MKEK dan MKDKI;
 - c. Rekomendasi mampu secara fisik maupun mental memberikan asuhan kepada pasien tanpa supervisi dari profesi dokter yang ditentukan;
 - d. Bila staf medis mengalami gangguan kesehatan, kecacatan tertentu, atau proses penuaan yang menghambat pelaksanaan kerja maka kepada yang bersangkutan dilakukan penugasan klinis ulang;
 - e. Jika seorang anggota staf medis mengajukan kewenangan baru terkait pelatihan spesialisasi canggih atau subspecialisasi maka dokumen kredensial harus segera diverifikasi dari sumber yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Keanggotaan staf medis mungkin tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak mempunyai teknologi medis khusus untuk mendukung kewenangan klinis tertentu. Sebagai contoh, seorang nefrolog melamar untuk memberikan layanan dialisis di rumah sakit bila



rumah sakit tidak memiliki pelayanan ini maka kewenangan klinis untuk melakukan haemodialisis tidak dapat diberikan.

BAB II



PENUGASAN STAF MEDIS

2.1. Proses Kredensial

Rumah sakit menyelenggarakan pengumpulan dokumen kredensial dari anggota staf medis yang diberi izin memberikan asuhan kepada pasien secara mandiri. Rumah sakit melaksanakan verifikasi terkini terhadap pendidikan, registrasi, izin, pengalaman, dan lainnya dalam kredensialing staf medis. Rumah sakit melaksanakan proses seragam dan transparan untuk menentukan penerimaan staf medis. Dokumen kredensial dan rekredensial meliputi :

- 1) STR, izin praktik yang masih berlaku;
- 2) File pelanggaran etik atau disiplin termasuk informasi dari sumber luar seperti dari MKEK dan MKDKI;
- 3) Rekomendasi mampu secara fisik maupun mental memberikan asuhan kepada pasien tanpa supervisi dari profesi dokter yang ditentukan;
- 4) Bila staf medis mengalami gangguan kesehatan, kecacatan tertentu, atau proses penuaan yang menghambat pelaksanaan kerja maka kepada yang bersangkutan dilakukan penugasan klinis ulang;
- 5) Jika seorang anggota staf medis mengajukan kewenangan baru terkait pelatihan spesialisasi canggih atau subspecialisasi maka dokumen kredensial harus segera diverifikasi dari sumber yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Keanggotaan staf medis mungkin tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak mempunyai teknologi medis khusus untuk mendukung kewenangan klinis tertentu. Sebagai contoh, seorang nefrolog melamar untuk memberikan layanan dialisis di rumah sakit bila rumah sakit tidak memiliki pelayanan ini maka kewenangan klinis untuk melakukan haemodialisis tidak dapat diberikan.

2.2. Penetapan Ulang

Penetapan ulang adalah proses tinjauan terhadap dokumentasi anggota staf medis untuk verifikasi :

- 1) Kelanjutan izin (licence);
- 2) Apakah anggota staf medis tidak terkena tindakan etik dan disiplin dari MKEK dan MKDKI;
- 3) Apakah tersedia dokumen untuk mendukung penambahan kewenangan klinis atau tanggung jawab di rumah sakit;
- 4) Apakah anggota staf medis mampu secara fisik dan mental memberikan asuhan dan pengobatan tanpa supervisi;
- 5) Informasi yang dibutuhkan untuk tinjauan ini dikumpulkan dari internal, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan setiap anggota staf termasuk juga dari sumber luar seperti organisasi profesi atau sumber instansi resmi. File kredensial dari seorang anggota staf medis harus menjadi sumber informasi yang dinamis dan selalu ditinjau secara teratur. Contohnya, jika seorang anggota staf menyerahkan sertifikat kelulusan sebagai hasil dari pelatihan spesialisasi khusus, kredensial baru ini harus diverifikasi segera dari sumber yang mengeluarkan sertifikat. Sama halnya, jika instansi dari luar (MKEK/ MKDKI) menyelidiki kejadian sentinel terkait seorang anggota staf medis dan memberi sanksi maka informasi ini harus digunakan untuk evaluasi muatan kewenangan klinis anggota staf medis. Untuk menjamin bahwa file staf medis lengkap dan akurat, file diperiksa paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali dan ada catatan di file tindakan yang diberikan atau tindakan tidak diperlukan sehingga penempatan staf medis dapat berlanjut.

Pertimbangan untuk merinci kewenangan klinis saat penetapan ulang mencakup hal-hal sebagai berikut :



- 1) Anggota staf medis dapat diberikan kewenangan klinis tambahan berdasar atas pendidikan dan pelatihan lanjutan. Pendidikan dan pelatihan diverifikasi dari sumber aslinya (lembaga pemerintah atau kolegium). Pemberian penuh kewenangan klinis tambahan mungkin ditunda sampai proses verifikasi lengkap atau jika dibutuhkan waktu harus dilakukan supervisi sebelum kewenangan klinis diberikan. Contoh, jumlah kasus yang harus disupervisi dari kardiologi intervensi;
- 2) Kewenangan klinis anggota staf medis dapat dilanjutkan, dibatasi, atau dihentikan berdasar atas:
 - a. Hasil dari proses peninjauan praktek profesional berkelanjutan.
 - b. Pembatasan kewenangan klinis dari organisasi profesi, KKI, MKEK, MKDKI, atau badan resmi lainnya.
 - c. Temuan rumah sakit dari hasil evaluasi kejadian sentinel atau kejadian lain.
 - d. Kesehatan staf medis.
 - e. Permintaan staf medis

2.3. Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Penentuan kompetensi seorang anggota staf medis terkait keputusan tentang layanan klinis yang diizinkan sering disebut dengan istilah pemberian kewenangan klinis dan penentuan ini merupakan keputusan yang sangat kritis bagi rumah sakit untuk melindungi keselamatan pasien dan juga mengembangkan mutu. Pertimbangan pemberian kewenangan klinis pada penugasan (appointment) pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Keputusan tentang kewenangan klinis yang akan diberikan kepada seorang staf medis didasarkan terutama atas informasi dan dokumentasi yang diterima dari sumber luar rumah sakit. Sumber luar ini dapat berasal dari program pendidikan spesialis, surat rekomendasi dari penempatan sebagai staf medis yang lalu, atau dari organisasi profesi, kolega dekat, dan setiap data informasi yang mungkin diberikan kepada rumah sakit. Secara umum, sumber informasi ini terpisah dari yang diberikan oleh institusi pendidikan seperti program dokter spesialis, tidak diverifikasi dari sumber kecuai ditentukan lain oleh regulasi rumah sakit, paling sedikit area kompetensi sudah dapat dianggap benar. Evaluasi praktik profesionalnya akan menjadi bahan validasi tentang kebenaran anggapan kompetensi ini.
- 2) Program pendidikan spesialis menentukan dan membuat daftar secara umum tentang kompetensinya di area diagnosis dan tindakan profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia mengeluarkan standar kompetensi atau kewenangan klinis. Perhimpunan profesi lain membuat dasar secara detail jenis/ tindakan medis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pemberian kewenangan klinis.
- 3) Di dalam setiap area spesialisasi proses untuk merinci kewenangan ini seragam;
- 4) Seorang dokter dengan spesialisasi yang sama dimungkinkan memiliki kewenangan klinis berbeda yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dan pelatihan tambahan, pengalaman, atau hasil kinerja yang bersangkutan selama bekerja, serta kemampuan motoriknya;
- 5) Keputusan kewenangan klinis di rinci dan akan direkomendasikan kepada pimpinan rumah sakit dalam sebuah area spesialisasi terkait dengan proses lain.
- 6) Penilaian kinerja staf medis berkelanjutan setiap tahun yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang berisi jumlah pasien per penyakit/ tindakan yang ditangani pertahun, rerata lama dirawat, serta angka kematiannya. Angka ILO dan kepatuhan terhadap PPK meliputi penggunaan obat, penunjang diagnostik, darah, produk darah, dan lainnya.
- 7) Hasil evaluasi praktik professional berkelanjutan (OPPE) dan terfokus (FPPE).
- 8) Hasil Pendidikan dan pelatihan tambahan dari pusat pendidikan, kolegium, perhimpunan profesi, dan rumah sakit yang kompeten mengeluarkan sertifikat.
- 9) Untuk kewenangan tambahan pada pelayanan risiko tinggi maka rumah sakit menentukan area pelayanan risiko tinggi seperti prosedur cathlab, pemberian obat kemoterapi, obat radioaktif, obat anestesi, dan lainnya. Prosedur dengan risiko tinggi tersebut maka staf medis dapat diberikan kewenangan klinis secara khusus. Prosedur risiko tinggi, obat-obat, atau layanan yang lain ditentukan di kelompok spesialisasi dan di rinci kewenangannya secara jelas. Beberapa prosedur mungkin digolongkan berisiko tinggi disebabkan oleh peralatan yang digunakan seperti dalam kasus penggunaan robot atau penggunaan tindakan dari jarak jauh melalui komputer. Juga pemasangan implan



yang memerlukan kalibrasi, presisi, dan monitor jelas membutuhkan kewenangan klinis secara spesifik.

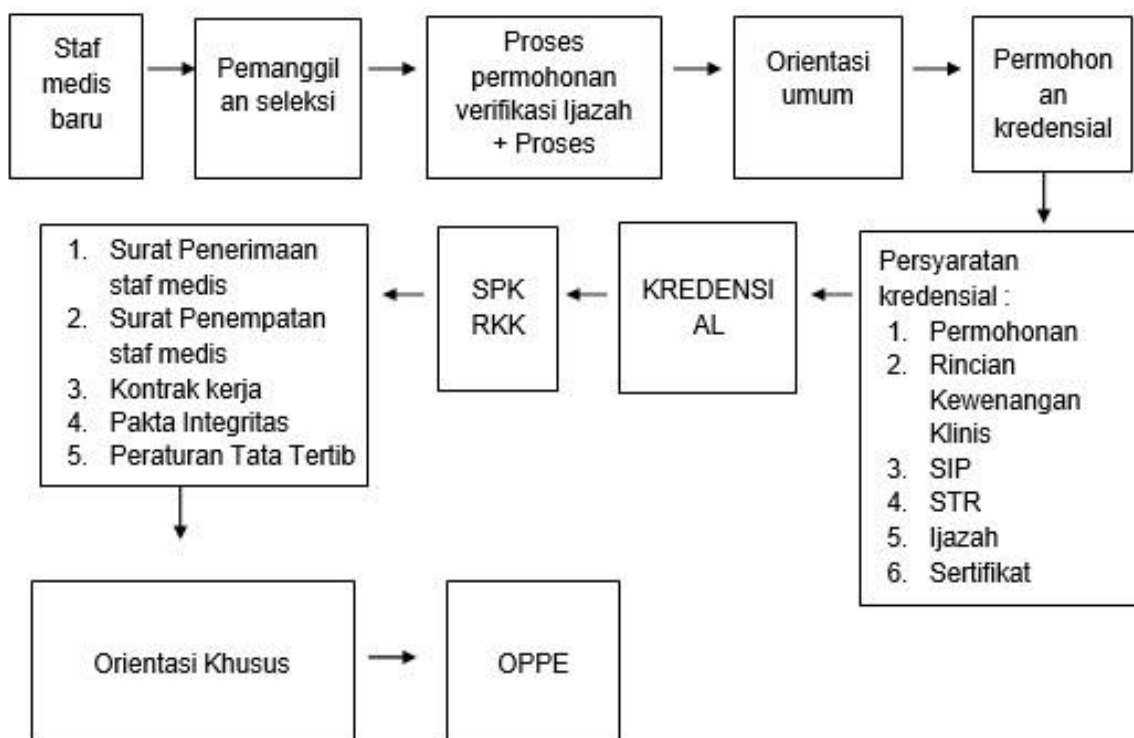
- 10) Kewenangan klinis tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak mempunyai peralatan khusus atau staf khusus untuk mendukung pelaksanaan kewenangan klinis. Sebagai contoh, seorang nefrolog kompeten melakukan dialisis atau kardiolog kompeten memasang sten tidak dapat diberi kewenangan klinis jika rumah sakit tidak memiliki peralatannya.

Jika anggota staf medis juga mempunyai tanggung jawab administrasi seperti ketua kelompok staf medis (KSM), administrator rumah sakit, atau posisi lain maka tanggung jawab peran ini diuraikan di uraian tugas atau job description. Rumah sakit menetapkan sumber utama untuk memverifikasi peran administrasi. Proses pemberian rincian kewenangan klinis:

- 1) Terstandar, objektif, berdasar atas bukti (evidence based).
- 2) Terdokumentasi di regulasi rumah sakit.
- 3) Aktif dan berkelanjutan mengikuti perubahan kredensial staf medis.
- 4) Diikuti semua lapisan keanggotaan staf medis.
- 5) Dapat dibuktikan bahwa prosedur yang digunakan efektif

Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis tersedia dan diumumkan kepada setiap staf medis serta ke semua unit pelayanan. Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis tersedia dalam bentuk tercetak maupun elektronik (softcopy) pada semua unit pelayanan untuk menjawab pertanyaan dari berbagai pihak termasuk pasien, apakah seorang staf medis berwenang melakukan tindakan klinis tertentu.

Alur Penerimaan dan Kredensial Staf Medis



BAB III KREDENSIAL STAF KEPERAWATAN



Rumah sakit perlu memastikan untuk mempunyai staf keperawatan yang kompeten sesuai dengan misi, sumber daya, dan kebutuhan pasien. Staf keperawatan bertanggungjawab untuk memberikan asuhan keperawatan pasien secara langsung. Sebagai tambahan, asuhan keperawatan memberikan kontribusi terhadap *outcome* pasien secara keseluruhan. Rumah sakit harus memastikan bahwa perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan dan harus spesifik terhadap jenis asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit memastikan bahwa setiap perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan, baik mandiri, kolaborasi, delegasi, serta mandat kepada pasien secara aman dan efektif dengan cara :

- 1) Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait perawat dan praktik keperawatan.
- 2) Mengumpulkan semua kredensial yang ada untuk setiap perawat, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, serta pengalaman terbaru dan diverifikasi dari sumber aslinya.
 - b. Bukti kompetensi terbaru melalui informasi dari sumber lain di tempat perawat pernah bekerja sebelumnya.
 - c. Surat rekomendasi dan/atau informasi lain yang mungkin diperlukan rumah sakit, antara lain riwayat kesehatan dan sebagainya.
- 3) Rumah sakit perlu melakukan setiap upaya untuk memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber dengan jalan mengecek ke website resmi ins titusi pendidikan pelah an melalui email dan surat tercatat. Pemenuhan standar mensyaratkan verifikasi sumber utama dilaksanakan untuk perawat yang akan dan sedang bekerja. Bila verifikasi tidak mungkin dilakukan seperti hilang karena bencana atau sekolahnya tutup maka hal ini didapatkan dari sumber resmi lain.

3.1. Tahapan Kredensial Perawat Baru



3.2. Pemberian Kewenangan Kepada Perawat Baru



Proses penerimaan perawat baru dimulai dengan seleksi administrasi, yang meliputi kelengkapan berkas data diri, lamaran, KTP, surat keterangan sehat. Setelah selesai administrasi perlu dilaksanakan kredensial kompetensi berdasarkan verifikasi keaslian ijazah. Verifikasi dilaksanakan dengan mengirimkan surat konfirmasi langsung kepada institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah, surat kelulusan uji kompetensi/uji profesi. Keaslian Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) juga perlu dicek kebenarannya, verifikasi dokumen ditujukan untuk menjamin keamanan pemberian asuhan keperawatan.

Assesmen kompetensi bidang pengetahuan secara tertulis dan lisan, sikap dan keterampilan dilaksanakan untuk menetapkan kewenangan klinis staf perawat baru dalam memberikan asuhan keperawatan. Kewenangan klinis SDM perawat baru mengacu pada perundang-undangan, jenjang karir, jabatan fungsional maupun Standar Kompetensi Keperawatan Nasional Indonesia (SKKNI) adalah dibawah supervise ketat untuk asuhan kritis atau dengan mengikuti model Preceptorship.

Orientasi dilaksanakan secara umum terkait mutu pelayanan RS, keamanan dan keselamatan pasien, serta orientasi khusus bidang keperawatan, seperti terkait asuhan keperawatan, etik dan caring. Setelah penerimaan akan dikeluarkan kewenangan klinis dan dilanjutkan perawat baru harus mendapatkan mentoring dan bimbingan dari preceptor yang telah ditunjuk apabila diperlukan perawat baru akan menjalani hands on yaitu proses pendalaman ketrampilan klinis yang bersifat berisiko, dan pendalaman ketrampilan klinis ini dilaksanakan dengan media bantuan di laboratorium menggunakan alat peraga dan tidak langsung kepada pasien. Perawat baru akan mendapatkan evaluasi yang berkelanjutan untuk akhirnya dinyatakan mempunyai RKK yang mandiri dan dapat diajukan rekredensial pada komite keperawatan.

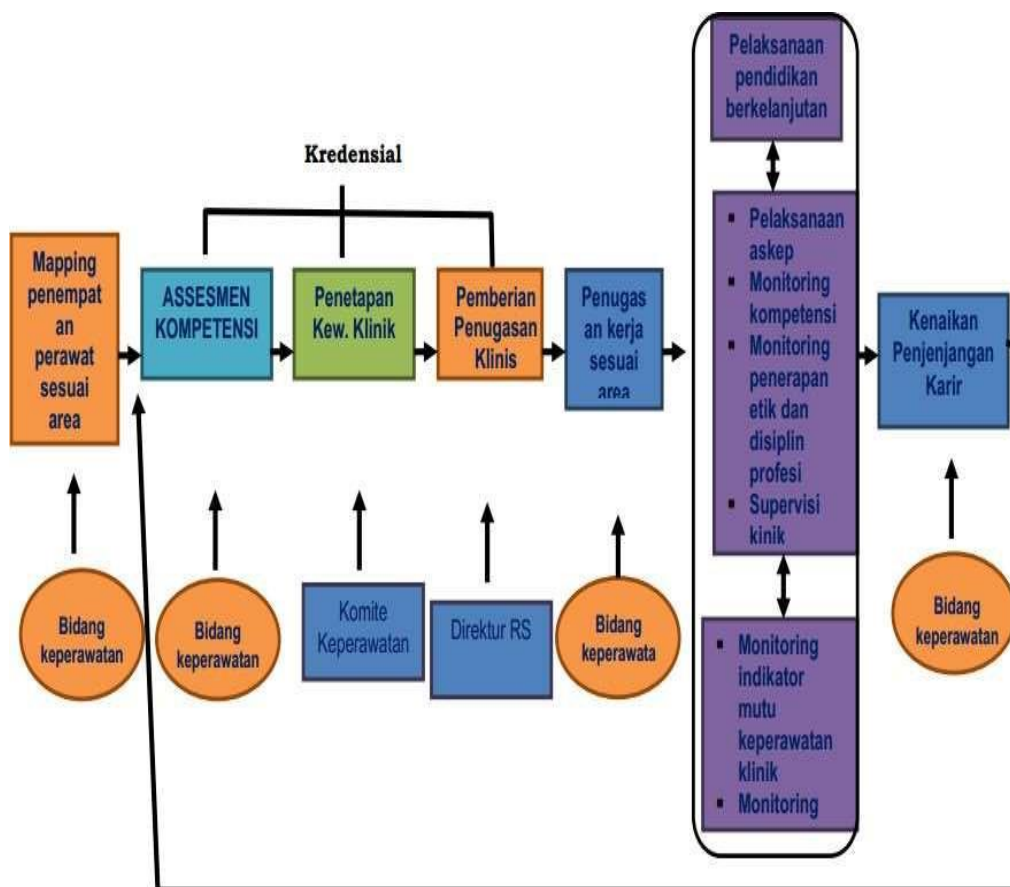
3.3. Rekredensial

Rekredensial dilaksanakan untuk menjamin bahwa asuhan yang diberikan oleh perawat adalah aman untuk pasien. Setelah proses preceptorship akan ada rekomendasi evaluasi progress kompetensi yang menjadi rekomendasi untuk kredensial kepada komite Keperawatan. Jika pada awalnya staf keperawatan baru punya beberapa kewenangan dibawah supervise bias diusulkan kredensial untuk menjadi kewenangan klinis yang mandiri. Rekredensial dilaksanakan terhadap kewenangan klinis yang awalnya tidak mandiri/dibawah supervise menjadi mandiri. Rekredensial juga dilaksanakan saat akan mengajukan kenaikan jenjang karir keperawatan dan assesmen diarahkan pada kemampuan dan kompetensi pada jenjang diatasnya. Rekredensial juga bisa dilaksanakan pada kondisi tertentu misalnya setelah cuti panjang atau setelah sembuh dari kondisi sakit.

Alur kredensial dimulai dengan mengadakan OPPE atau FPPE secara berkesinambungan kemudian aspek kompetensi yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kemampuan dalam membuat keputusan klinis. Dokumen assesmen kompetensi divalidasi melalui logbook dan potofolio. Assesmen kompetensi dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari atasan langsung dan juga tim yang ditunjuk dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan evaluasi. Metode assesmen kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk metode kasus, presentasi berbasis *evidence based practice* dan apabila diperlukan dapat dilakukan validasi melalui kemampuan ketrampilan keperawatan yang bersifat berisiko tinggi terhadap keselamatan pasien.

Hasil kredensial perawat berupa rincian kewenangan klinis menjadi landasan untuk membuat uraian tugas, wewenang, dan tanggungjawab klinis di unit pelayanan tempat perawat tersebut ditugaskan. Hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan didokumentasikan dalam file kredensial perawat tersebut atau file lainnya.

Alur Rekredensial Perawat



Jenis dan Kualifikasi Perawat Klinik

Jenis PK	Kualifikasi	Masa
Pra PK	- DIII Keperawatan atau Ners pengalaman kerja 0 tahun - Mempunyai sertifikat BHD	- DIII : 0-1 tahun - Ners : 0-1 tahun
PK I	- DIII Keperawatan atau Ners - Pengalaman kerja ≥1 tahun - Mempunyai sertifikat pra klinik	- DIII : 3-6 tahun - Ners : 4-7 tahun
PK II	- DIII Keperawatan dengan pengalaman kerja ≥ 4 tahun - Ners dengan pengalaman kerja ≥ 3 tahun - Mempunyai sertifikat PK I	- DIII : 6-9 tahun - Ners : 7-9 tahun
PK III	- DIII Keperawatan dengan pengalaman kerja ≥ 10 tahun dan mempunyai sertifikat PK II - Ners dengan pengalaman kerja ≥ 7 tahun dan mempunyai sertifikat PK II - Ners Spesialis I dengan pengalaman kerja 0 tahun	- DIII : 9-12 tahun - Ners : 7-9 tahun - Ners Sp I : 2-4 tahun
PK IV	- Ners dengan pengalaman kerja ≥ 13 tahun - Ners Spesialis I dengan pengalaman kerja ≥ 2 tahun - Mempunyai sertifikat PK III	- Ners : 9-12 tahun - Ners Sp I : 6-9 tahun
PK V	- Ners Spesialis dengan pengalaman kerja ≥4 tahun mempunyai sertifikat PK IV - Ners Spesialis II (konsultan) dengan pengalaman kerja 0 tahun	Hingga masa pensiun

BAB IV



KREDENSIAL STAF KLINIS PEMBERI ASUHAN LAINNYA DAN STAF KLINIS LAINNYA

Rumah sakit mempekerjakan atau dapat mengizinkan berbagai profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya untuk memberikan asuhan dan pelayanan kepada pasien atau berpartisipasi dalam proses asuhan pasien. Contohnya, para profesional ini termasuk bidan, nutrisisionis, apoteker, fisioterapis, teknisi transfusi darah, penata anestesi, dan lainnya. Bila pendidikannya profesi maka termasuk golongan profesional pemberi asuhan (PPA), sedangkan bila pendidikannya vokasi maka kewenangannya adalah sebagai PPA lainnya. Bila profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya tersebut yang diizinkan bekerja atau berpraktik di rumah sakit maka rumah sakit bertanggungjawab untuk melakukan proses kredensialing. Rumah sakit harus memastikan bahwa profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya tersebut kompeten untuk ikut memberikan asuhan dan harus menetapkan jenis asuhan serta pengobatan yang diizinkan bila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit perlu memastikan mempunyai profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya yang kompeten sesuai dengan misi, sumber daya, dan kebutuhan pasien. Profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya bertanggungjawab memberikan asuhan pasien secara langsung. Sebagai tambahan, asuhan memberikan kontribusi terhadap outcome pasien secara keseluruhan. Rumah sakit harus memastikan bahwa profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya yang kompeten untuk memberikan asuhan dan harus spesifik terhadap jenis asuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit memastikan bahwa setiap profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya yang kompeten memberikan asuhan, baik mandiri, kolaborasi, delegasi, serta mandat kepada pasien secara aman dan efektif dengan cara :

- 1) Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya dan praktik profesinya.
- 2) Mengumpulkan semua kredensial yang ada untuk setiap profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan serta pengalaman terbaru, dan diverifikasi dari sumber aslinya.
 - b. Bukti kompetensi terbaru melalui informasi dari sumber lain di tempat profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya pernah bekerja sebelumnya;
 - c. Surat rekomendasi dan/atau informasi lain yang mungkin diperlukan rumah sakit, antara lain riwayat kesehatan dan sebagainya.
- 3) Rumah sakit perlu melakukan setiap upaya untuk memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber dengan jalan mengecek ke website resmi dari institusi pendidikan pelatihan, melalui email, surat tercatat. Pemenuhan standar mensyaratkan verifikasi sumber utama dilaksanakan untuk profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya yang akan dan sedang bekerja. Bila verifikasi tidak mungkin dilakukan seperti hilang karena bencana atau sekolahnya tutup maka hal ini didapat dari sumber resmi lain.
- 4) Melakukan setiap upaya memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber dengan jalan mengecek ke website resmi dari institusi pendidikan pelatihan melalui email dan surat tercatat. Pemenuhan standar mensyaratkan verifikasi sumber aslinya dilaksanakan untuk profesional pemberi asuhan dan PPA lainnya yang akan dan sedang bekerja. Bila verifikasi tidak mungkin dilakukan seperti hilangnya dokumen karena bencana atau sekolahnya tutup maka hal ini dapat diperoleh dari sumber resmi lain. File kredensial



setiap profesional pemberi asuhan dan PPA lainnya harus tersedia dan dipelihara serta diperbaharui secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran klinis yang penting seperti profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya mengharuskan staf tersebut berpartisipasi secara proaktif dalam program peningkatan mutu klinis rumah sakit. Rumah sakit melakukan evaluasi kinerja individu profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya bila ada temuan dalam aktivitas peningkatan mutu. Hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan didokumentasikan dalam file kredensial profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya tersebut atau file lainnya.



BAB V

TATA LAKSANA

5.1. Tata Laksana Kredensial

- 1) Staf medis, staf keperawatan dan tenaga kesehatan lain melakukan permohonan untuk memperoleh kewenangan klinis dengan metode *self assessment*.
- 2) Mitra bestari mengkaji dan memberikan rekomendasi tindakan medis yang diajukan oleh pemohon.
- 3) Pimpinan rumah sakit menerbitkan surat penugasan (*clinical appointment*) berdasarkan rekomendasi dari mitra bestari yang berlaku untuk periode tertentu secara periodic.

5.2. Tahap Pertama : Permohonan untuk memperoleh kewenangan klinis

- 1) Setiap staf medis, staf keperawatan dan tenaga kesehatan lain mengajukan permohonan pimpinan rumah sakit untuk melakukan tindakan. Staf medis, staf keperawatan dan tenaga kesehatan lain tersebut mengisi beberapa formulir yang disediakan rumah sakit antara lain daftar tindakan medis yang ingin dilakukannya sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Staf medis, staf keperawatan dan tenaga kesehatan lain tersebut memilih tindakan yang tertera dalam formulir daftar tindakan medis yang tertera dalam formulir daftar tindakan medis tersebut dengan cara mencontreng/ mengisi angka 1-3 (dengan maksud 1: dapat dilakukan secara mandiri/diberikan kewenangan, 2: Dibawah supervise, 3: tidak diberi kewenangan), dan menyerahkan copy semua dokumen yang di persyaratkan oleh rumah sakit untuk diserahkan kepada komite/ tim adhoc untuk ditindak lanjuti.

5.3. Tahap Kedua : Kajian Mitra Bestari

- 1) Komite/ tim adhoc menugaskan sub komite kredensial untuk memproses permohonan tersebut.
- 2) Subkomite kredensial menyiapkan mitra bestari yang berjumlah sekitar 4 hingga 6 orang sesuai dengan bidang keahlian yang akan dinilai. Mitra bestari tersebut tidak harus anggota sub komite kredensial, bahkan dapat dari luar rumah sakit bila di perlukan. Para mitra bestari yang bertugas tersebut dapat terdiri dari beberapa tenaga kesehatan sesuai dengan tenaga kesehatan yang akan dilakukan kredensialing.
- 3) Misalnya, bila seorang analis mengajukan permohonan untuk melakukan plebotomi, maka mitra bestari yang dipilih dapat terdiri dari spesialis patologi klinik, dan analis lain. Dengan demikian kelompok mitra bestari tersebut dapat berbeda untuk setiap tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan kewenangan klinis.
- 4) Mitra bestari mengkaji setiap tindakan medis yang diajukan oleh pemohon. Pengkajian setiap tindakan medis yang diajukan oleh pemohon tersebut dilakukan secara objektif didasarkan pada suatu buku putih (white paper). Sebuah buku putih untuk tindakan medis tertentu yang memuat syarat – syarat kapan seorang analis dianggap kompeten melakukan plebotomi. seorang analis harus menjalani pelatihan plebotomi, dan telah menangani sejumlah kasus tertentu dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan buku putih (white paper) tersebut mitra bestari dapat merekomendasikan atau menolak permohonan tindakan yang diajukan.
- 5) Selain menilai kompetensi, mitra bestari juga menilai kemampuan pemohon berdasarkan kesehatan fisik dan mental untuk setiap tindakan medis yang diajukan. Rumah sakit mempersiapkan sarana dan prasarana dan panel tenaga kesehatan untuk melakukan uji kesehatan fisik dan mental tersebut.
- 6) Pada akhir proses kredensial, mitra bestari merekomendasikan sekelompok tindakan tertentu yang boleh dilakukan oleh pemohon di rumah sakit tersebut. Selanjutnya komite/ tim adhoc mengkaji kembali rekomendasi tersebut dan mengadakan beberapa modifikasi bila diperlukan dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan rumah sakit.



5.4. Tahap Ketiga : Penerbitan Surat Penugasan Klinis

- 1) Pimpinan rumah sakit menerbitkan surat penugasan kepada tenaga kesehatan pemohon berdasarkan rekomendasi tersebut. Kepala rumah sakit dapat saja meminta komite/tim Adhoc untuk mengkaji ulang rekomendasi tersebut bersama pihak manajemen rumah sakit bila dianggap perlu.
- 2) Surat penugasan tersebut memuat daftar sejumlah kewenangan klinis untuk melakukan tindakan bagi tenaga kesehatan pemohon. Setiap tenaga medis dalam satu bidang spesialisasi tertentu dapat saja memiliki daftar kewenangan klinis yang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya dengan bidang spesialisasi yang sama. Suatu tindakan medis tertentu di rumah sakit hanya boleh dilakukan oleh dokter yang telah memiliki surat kewenangan klinis berdasarkan surat penugasan.
- 3) Daftar kewenangan klinis seorang staf medis, staf keperawatan dan tenaga kesehatan lain dapat saja mengajukan tambahan kewenangan klinis yang tidak dimiliki dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan rumah sakit. Selanjutnya komite medis akan melakukan proses kredensial khusus untuk tindakan tersebut, dan akan memberikan rekomendasinya kepada pimpinan rumah sakit. Namun sebaliknya, kewenangan klinis tertentu dapat saja dicabut, baik untuk sementara atau seterusnya karena alasan tertentu

BAB VI PENUTUP



Pada dasarnya kredensial tetap ditujukan untuk menjaga keselamatan pasien, sambil tetap membina kompetensi seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa Komite dan tim adhoc memegang peranan penting dalam proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis untuk setiap tenaga kesehatan.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 01 April 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes